UE C.1 · SEMESTRE 1 · COURS DU 9 NOVEMBRE 2026

Prévention et promotion de la santé

Fiche de révision écrite

Cours de Sara Kerbouai · Faculté de médecine Paris-Saclay · Support commenté et explications de cours

Comprendre pour savoir classer une intervention

Définir la prévention et la promotion de la santé, distinguer les classifications et analyser une action en reliant son objectif, ses bénéficiaires et ses déterminants.

Priorités indiquées dans le cours

Notions signalées par les titres sur fond violet/bordeaux ou les encadrés rouges : à connaître. Autres illustrations : à comprendre. Les exemples de politiques ne sont pas à apprendre par cœur.

Lecture à deux niveaux

Essentiel : définitions et distinctions. Pour comprendre : explications et exemples. Les notes de cours précisent les raisonnements utiles en stage et pour l'évaluation.

Trois critères pour classer une action

Critère	Question à poser
Moment	Avant la maladie, détection précoce, complications ou juste soin ?
Échelle	Pour une personne ou une population ?
Population	Universelle, orientée / sélective ou ciblée / indiquée ?

Sommaire rapide — accès direct aux chapitres

Santé publique · p. 2
Niveaux de prévention · p. 4
Échelle et population · p. 6
Promotion et Ottawa · p. 8
Comportements · p. 10
Les quatre approches · p. 12
Éthique et posture · p. 14
Politiques : exemples · p. 15
Méthode d'analyse · p. 18
Pièges QCM · p. 19
Synthèse générale · p. 20
Définitions et mots-clés · p. 21

Réflexe de révision

Commencer par l'objectif de l'intervention, puis justifier chaque classement. Prévention et promotion peuvent se compléter ; une action peut mobiliser plusieurs niveaux.

01 Situer la prévention dans la santé publique

ESSENTIEL

La santé publique vise à préserver et améliorer la santé physique, mentale et sociale de l'ensemble d'une population par une action collective et concertée. Elle dépasse les soins apportés à une personne malade.

Une logique de population et des déterminants multiples

La santé publique associe la prévention des maladies, la protection face aux menaces, l'amélioration du milieu de vie et l'organisation des services. La définition présentée dans le cours insiste aussi sur les conditions sociales permettant à chacun de maintenir sa santé. Un soin individuel s'intéresse à une personne ; une action de santé publique prend également en compte la répartition des risques et des besoins dans la population.

Un déterminant de santé est un facteur personnel, social, économique ou environnemental qui influence l'état de santé, favorablement ou défavorablement. L'âge et le patrimoine génétique ne se modifient pas de la même manière que les comportements ou les conditions de vie. Les revenus, le travail, le logement, l'entourage, l'environnement et les politiques publiques participent aussi à la santé.

Note de cours — « réseaux sociaux »

Dans cette approche, les réseaux sociaux désignent d'abord les relations entre personnes, la famille, le voisinage et les communautés. Il ne s'agit pas seulement des plateformes numériques.

Trois grandes étapes pour comprendre l'évolution des besoins

Période	Préoccupations et évolution
Avant le XXe siècle	Les épidémies, les maladies infectieuses et les famines occupent une place majeure. Les actions d'isolement restent longtemps locales.
Transition des XIXe–XXe siècles	Les progrès en microbiologie, la vaccination, les antibiotiques et les politiques d'hygiène permettent d'agir plus efficacement sur les infections. La loi de 1902 illustre l'organisation collective : déclarations obligatoires, vaccinations, hygiène et surveillance.
Période contemporaine	L'allongement de la vie et le vieillissement s'accompagnent d'une place croissante des maladies chroniques. La prévention et la promotion de la santé deviennent essentielles pour la qualité de vie et la réponse du système de santé.

Comprendre l'espérance de vie à la naissance

Une espérance de vie historiquement basse ne signifie pas que personne ne vivait longtemps. Une forte mortalité des nourrissons et des enfants abaisse la moyenne. Le cours relie l'amélioration de cette espérance de vie aux progrès sanitaires, à l'hygiène, à la vaccination et aux traitements.

Les cinq fonctions essentielles

Fonction	Ce qu'elle recouvre
Surveillance de l'état de santé	Observer les indicateurs et les décès, repérer une évolution inhabituelle : c'est la veille sanitaire.
Protection des populations	Répondre à une menace et gérer une crise : épidémie, canicule, autres risques pour la santé.
Prévention des maladies	Éviter leur apparition, les détecter tôt ou limiter leurs conséquences.
Promotion de la santé	Donner aux populations les moyens de mieux agir sur leur santé.
Organisation du système de santé	Organiser les services et les ressources pour répondre aux besoins.

Pour les infirmiers, ces fonctions se traduisent notamment par l'information, le repérage des risques, l'accompagnement des changements et l'orientation vers les ressources adaptées. Prévenir réduit les difficultés vécues par les personnes et peut limiter la demande de soins curatifs. Ces notions préparent les actions à mener en stage et dans la pratique infirmière.

02 Prévention : raisonner selon l'histoire de la maladie

DÉFINITION À CONNAÎTRE

La prévention rassemble les mesures visant à éviter ou réduire le nombre ou la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Son objectif ne se limite donc pas à empêcher une première maladie.

Identifier ce que l'intervention cherche à éviter

L'histoire naturelle d'une maladie permet de distinguer plusieurs moments : bonne santé par rapport à la maladie considérée ; début du processus biologique ; phase permettant une détection précoce ; diagnostic clinique ; évolution vers guérison, séquelles, complications ou décès. Une maladie peut exister avant de provoquer des symptômes. Le niveau de prévention dépend de l'objectif de l'action à ce moment de l'histoire.

Niveau	Situation et objectif	Exemples du cours
Primaire	Avant l'apparition de la maladie visée : réduire les facteurs de risque et éviter qu'elle survienne.	Vaccination, arrêt du tabac, amélioration de l'alimentation, gestes barrières.
Secondaire	Une maladie peut déjà exister sans être connue : la repérer tôt et permettre une prise en charge précoce.	Dépistage des cancers ; repérage de troubles visuels chez l'enfant.
Tertiaire	La maladie est connue : limiter les rechutes, les séquelles, les incapacités et les complications.	Surveillance des pieds chez une personne diabétique ; rééducation après AVC ; prévention des escarres.
Quaternaire	Rechercher le juste soin : éviter la surmédicalisation et les interventions inutiles ou défavorables.	Ne pas prescrire un antibiotique pour une rhinite virale ; discuter une prise en charge disproportionnée.

Prévention primaire : agir avant la maladie visée

Le raisonnement est : une personne est exposée à un risque, mais la maladie considérée n'est pas apparue ; on agit pour réduire ce risque. L'arrêt du tabac est présenté comme une prévention primaire des cancers et des maladies respiratoires ou cardiovasculaires. La vaccination et les gestes barrières sont d'autres exemples. Une action n'est pas secondaire uniquement parce qu'un facteur de risque existe déjà.

Prévention secondaire : détecter plus tôt pour agir plus tôt

Le dépistage recherche une maladie qui pourrait être présente alors que la personne ne la connaît pas ou n'en perçoit pas les signes. Le but est d'améliorer les possibilités de traitement, de limiter la gravité et, pour certaines infections, d'empêcher leur transmission. Il ne faut pas confondre absence de symptômes et absence de maladie.

Exemple — dépister n'est pas empêcher l'apparition

La mammographie de dépistage ou le dépistage colorectal cherchent à reconnaître une maladie déjà possible afin de la prendre en charge. Le cours cite aussi les troubles visuels des jeunes enfants : le raisonnement ne concerne donc pas uniquement les cancers.

Prévention tertiaire : limiter les conséquences d'une maladie connue

Les actions sont souvent multidisciplinaires : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes et autres professionnels contribuent à la prise en charge. Surveiller une glycémie ou les pieds d'une personne diabétique, prévenir les escarres d'une personne alitée, soutenir psychologiquement un patient et rééduquer après un traumatisme ou un AVC répondent à cette logique.

Note de cours — comprendre le pied diabétique

Une neuropathie peut diminuer la sensibilité du pied : une lésion peut alors passer inaperçue puis se compliquer. La surveillance ne cherche pas ici à découvrir le diabète, déjà connu ; elle vise à éviter ses complications. Le mot « dépistage » employé dans une action ne suffit donc pas, à lui seul, à choisir le niveau de prévention.

La rééducation cherche à améliorer les capacités fonctionnelles et à limiter le handicap. L'explication orale souligne qu'une réduction de l'activité peut entretenir une perte musculaire et une nouvelle baisse de mobilité. L'objectif est une amélioration adaptée à la personne, sans promettre une récupération complète.

Prévention quaternaire : peser bénéfices et risques

Le juste soin consiste à se demander si l'intervention proposée apporte réellement un bénéfice à cette personne et si ses risques sont acceptables. Une réflexion pluridisciplinaire et les connaissances scientifiques éclairent la décision. Éviter un traitement inutile est une action de soin raisonnée ; ce n'est pas renoncer à toute prise en charge.

Exemples — deux situations de juste soin

Pour une rhinite virale, le cours explique l'absence de bénéfice d'un antibiotique et les risques d'effets indésirables ou d'antibiorésistance. Dans une situation de grande fragilité avec infection sévère, il présente une discussion collective sur la proportionnalité d'une réanimation. Ce dernier exemple illustre un raisonnement individuel, pas une décision automatique fondée sur l'âge.

À retenir — une question par niveau

Primaire : éviter quelle maladie ? Secondaire : reconnaître plus tôt quelle maladie possible ? Tertiaire : limiter quelles conséquences d'une maladie connue ? Quaternaire : éviter quel soin inutile ou disproportionné ?

03 Distinguer échelle de l'action et population concernée

Trois classifications complémentaires

Le cours utilise trois critères différents : le moment d'intervention dans l'histoire de la maladie ; l'échelle individuelle ou collective ; le type de population auquel l'action s'adresse. Ces classifications ne se remplacent pas. Une même action peut être décrite avec un terme de chacune, à condition de justifier le critère utilisé.

Échelle	Définition et exemples
Individuelle	Action adaptée à une personne, à sa situation et à ses facteurs de risque : protection solaire selon le phototype, lavage des mains, bilan demandé en fonction de facteurs personnels.
Collective	Action organisée à l'échelle d'une population : campagne de vaccination, dépistage organisé, amélioration des conditions de vie ou de travail.

La classification de Gordon présentée dans le cours

Type	Population et objectif	Exemple
Universelle	L'ensemble d'une population, sans distinction de niveau de risque individuel ; réduire le risque global.	Messages généraux sur la nutrition ou l'activité physique.
Orientée / sélective	Un groupe présentant un risque statistiquement plus élevé que la moyenne ; réduire le risque dans ce groupe.	Prévention du harcèlement chez les adolescents ; vaccination des nourrissons.
Ciblée / indiquée	Des personnes identifiées individuellement par leurs facteurs de risque ; éviter l'apparition ou l'aggravation d'un problème chez elles.	Surveillance du pied d'un patient diabétique ; prise en charge individualisée d'une consommation problématique.

Note de cours — le terme « ciblée »

Dans cette classification, « ciblée / indiquée » est une catégorie précise et individualisée. Dans le langage courant, toute campagne peut avoir une « cible ». Ne pas employer ce sens large pour effacer la distinction avec la prévention orientée.

Appliquer simultanément les trois critères

Action et objectif	Classement justifié
Campagne de vaccination des nourrissons	Primaire : empêcher la maladie visée ; collective : campagne organisée ; orientée : groupe d'âge particulier.
Dépistage organisé d'un cancer dans la population concernée	Secondaire : rechercher une maladie possible ; collectif : dispositif organisé ; orienté : population définie par le programme.
Surveillance des pieds d'un patient dont le diabète est connu	Tertiaire : éviter une complication ; individuelle : suivi de cette personne ; ciblée : risque personnel identifié.
Messages nutritionnels généraux diffusés à la population	Primaire : prévenir des maladies ; collectif : diffusion large ; universel : ensemble de la population concernée.

Une campagne visible par tout le monde peut proposer une action destinée à un groupe précis. Il faut distinguer le public qui voit le message du public auquel l'intervention s'adresse réellement. Pour les exemples discutables, on commence par décrire le dispositif et son objectif avant de donner un classement.

À retenir

Collectif ne signifie pas automatiquement universel : une campagne collective peut être orientée vers les nourrissons ou une classe d'âge. Individuel et ciblé sont proches dans plusieurs exemples, mais répondent à deux questions différentes : à quelle échelle agit-on et sur quels critères choisit-on les personnes ?

04 Promotion de la santé et charte d'Ottawa

DÉFINITION À CONNAÎTRE

La charte d'Ottawa, en 1986, définit la promotion de la santé comme un processus donnant aux populations davantage de contrôle sur leur propre santé et les moyens de l'améliorer. La participation des personnes, malades et non malades, est essentielle.

Renforcer les capacités et transformer les conditions de vie

La promotion de la santé associe deux mouvements : renforcer les aptitudes et capacités des individus et des communautés ; améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales. Elle cherche à rendre possible la maîtrise des déterminants de santé. Elle ne se résume donc ni à une affiche ni à une injonction à mieux se comporter.

Les cinq axes d'Ottawa	Sens et illustration
Élaborer des politiques pour la santé	Prendre en compte les effets sanitaires des décisions : urbanisme, alimentation, fiscalité, travail.
Créer des environnements favorables	Faciliter concrètement les choix favorables : pistes cyclables, espaces verts, lieux sans tabac.
Renforcer l'action communautaire	Faire participer les citoyens aux décisions et aux projets concernant leur santé.
Développer les aptitudes individuelles	Développer les connaissances et compétences : éducation pour la santé et littératie en santé.
Réorienter les services de santé	Accorder davantage de place à la prévention et à la promotion de la santé, en complément des soins curatifs.

Note de cours — action communautaire

L'exemple donné est celui d'habitants qui se réunissent et construisent localement un projet de santé. Le rôle actif de la communauté compte : un message national reçu par beaucoup de personnes n'est pas, pour cette seule raison, une action communautaire.

Éducation pour la santé : informer et permettre d'agir

L'éducation pour la santé crée volontairement des occasions d'apprendre, grâce à une communication qui améliore les connaissances et les aptitudes utiles à la santé. Elle informe sur les risques et les moyens d'action, mais vise aussi l'autonomie et la capacité de prendre des décisions éclairées, dans les conditions de vie réelles des personnes.

Connaître un message ne signifie pas savoir comment le mettre en pratique. Le cours propose de partir du quotidien : comment une personne pourrait-elle intégrer une activité physique à ses déplacements ou à son organisation ? L'échange sert à construire une possibilité concrète, acceptable et compatible avec sa situation.

Application — passer du message au projet

Dire « bougez davantage » transmet une information. Discuter avec la personne de son trajet, des possibilités de marche, de ses habitudes et de ses contraintes aide à transformer cette information en action. Le soignant écoute et accompagne l'acquisition de compétences.

Des outils de communication adaptés

Le support présente SantéBD pour rendre des sujets médicaux plus compréhensibles et faciliter la communication avec les patients. Il cite aussi les ressources de Santé publique France : Manger Bouger, les supports sur le tabac, la parentalité et la santé sexuelle. Ces outils soutiennent l'échange ; ils ne remplacent pas l'explication adaptée à la personne.

À retenir

La prévention cherche à éviter des maladies ou leurs conséquences. La promotion de la santé cherche à accroître les moyens d'agir et les ressources favorables à la santé. Les deux démarches sont complémentaires et peuvent être présentes dans une même intervention.

05 Comprendre les comportements et leurs déterminants

ESSENTIEL

Un comportement de santé est une action, une habitude ou une conduite qui influence la santé, favorablement ou défavorablement : alimentation, activité physique, consommation de substances, vaccination, prise d'un traitement ou recours aux soins.

Savoir n'est pas toujours pouvoir changer

Famille de facteurs	Freins et leviers possibles
Personnels	Connaissances, motivation, confiance en soi, habitudes, croyances, expériences et capacités physiques.
Sociaux et culturels	Soutien de l'entourage, normes du groupe, représentations sociales, stigmatisation.
Socioéconomiques et environnementaux	Revenus, conditions de vie, prix, proximité d'espaces verts, équipements et possibilités de déplacement.
Organisationnels	Accessibilité des professionnels et des services de soins ou de prévention ; organisation du système de santé.

Deux exemples à comparer

Un parc ou une piste cyclable entre domicile et travail peut faciliter une activité physique déjà souhaitée. À l'inverse, des contraintes économiques peuvent orienter l'achat d'un repas malgré la connaissance des messages nutritionnels. Les connaissances comptent, mais l'environnement peut rendre l'action plus ou moins réalisable.

Une difficulté à changer n'est donc pas réductible à un manque de volonté. Le raisonnement infirmier doit rechercher les obstacles personnels, sociaux, matériels et organisationnels. Un défaut d'accès aux soins peut, par exemple, empêcher un dépistage même lorsque la personne en comprend l'intérêt.

Les nudges : orienter un choix sans l'interdire

Un nudge est une modification modeste et ingénieuse de l'environnement qui encourage un comportement sans sanctionner, faire la morale ni supprimer la liberté de choix. Il agit notamment sur ce qui est visible, facile ou attractif au moment de décider. Le cours l'illustre par les escaliers rendus plus engageants, le Nutri-Score et la présentation des aliments.

Exemple — placer les fruits au premier plan

Dans l'expérience présentée, les fruits deviennent plus visibles et les desserts sucrés passent au second plan. Les achats de fruits augmentent. L'explication à retenir est le rôle de l'organisation de l'environnement dans le choix, plutôt que la mémorisation d'un chiffre d'efficacité.

Le cours distingue aussi des nudges à objectif environnemental, comme des dispositifs ludiques pour jeter les mégots ou trier les déchets. Ils illustrent le mécanisme d'incitation, même si leur objectif immédiat n'est pas une intervention de santé.

Représentations sociales : un même objet, plusieurs significations

Les représentations sociales sont des croyances, connaissances et opinions produites et partagées par les membres d'un groupe à propos d'un objet social. Elles dépendent de l'histoire, des expériences et du contexte du groupe. Elles orientent l'interprétation d'un message et les comportements.

Objet : le tabac	Représentation et effet sur la compréhension
Style, maturité, liberté	Des images publicitaires ou culturelles peuvent présenter le fait de fumer comme valorisant.
Convivialité et sociabilité	La pause cigarette peut être associée au groupe, aux collègues et au moment partagé.
Maladie et risque	Les soignants peuvent d'abord penser aux atteintes respiratoires, cardiovasculaires et aux cancers.

> **Note de cours — écouter avant de convaincre**
>
> Pour une personne, le sport peut évoquer le plaisir, la détente ou le dépassement de soi ; pour une autre, la douleur, la compétition ou la peur d'être moins capable. L'accompagnement commence par comprendre ce que l'activité représente pour elle, au lieu de supposer qu'elle partage le point de vue du soignant.

Changer une représentation ou lutter contre la stigmatisation peut faciliter le recours aux soins. L'exemple de la santé mentale montre qu'une image négative d'une maladie peut empêcher une personne de reconnaître ses difficultés ou de demander de l'aide.

06 Les quatre approches de la promotion de la santé

1. L'approche socio-écologique : agir à plusieurs niveaux

La santé d'une personne dépend de ses caractéristiques et de ses comportements, mais aussi de son entourage et de son contexte social, économique et culturel. Agir uniquement sur l'individu peut être insuffisant : les autres niveaux peuvent soutenir ou freiner les changements.

Niveau	Ce qui est concerné	Exemple du cours
Individuel / intrapersonnel	Caractéristiques, motivation et capacités de la personne.	Connaissances sur l'alimentation ; capacité à pratiquer une activité.
Interpersonnel	Relations avec l'entourage.	Famille qui prépare des repas équilibrés ou soutient une consultation.
Organisationnel / environnemental	Structures fréquentées et leur fonctionnement.	Cantine scolaire ou d'entreprise proposant des repas équilibrés.
Communautaire	Quartier, ville, communauté.	Espaces verts, pistes cyclables, projets locaux.
Politiques publiques	Lois et décisions des pouvoirs publics.	Décisions de protection contre le tabac, politiques alimentaires.

Application — une intervention peut toucher plusieurs niveaux

Une action locale favorisant l'activité physique peut venir d'une politique nationale, mobiliser des clubs et des salles de sport, et s'adresser aux habitants d'un quartier. Il faut repérer les niveaux réellement mobilisés plutôt que chercher systématiquement une seule case.

2. L'approche par milieux de vie : intervenir là où l'on vit

Cette approche prend pour point d'entrée les lieux de la vie quotidienne : écoles, universités, entreprises, quartiers ou villes. Elle transforme leurs conditions pour les rendre favorables à la santé. Une cantine équilibrée agit dans l'école ou le travail ; des pistes cyclables et espaces verts agissent dans la ville.

Les deux premières approches sont liées : l'approche socio-écologique décrit plusieurs niveaux d'influence ; l'approche par milieux de vie choisit des lieux concrets où agir. L'école est un exemple de milieu permettant d'accompagner les apprentissages et les habitudes dès l'enfance.

3. L'approche salutogénique : chercher ce qui produit la santé

Une vision dichotomique oppose deux états : malade ou en bonne santé. Le continuum de santé propose une lecture dynamique : la présence d'une maladie ne résume pas toute la santé d'une personne. Ses capacités, son bien-être, sa vie sociale et ses ressources peuvent évoluer.

Approche pathogénique	Approche salutogénique
Étudier ce qui conduit à la maladie : la pathogenèse.	Étudier ce qui conduit vers la santé : la salutogenèse.

Approche pathogénique	Approche salutogénique
Rechercher et réduire les facteurs de risque ; prévenir et soigner la maladie.	Identifier et renforcer les ressources favorables à la santé et les moyens d'agir.
Le cours y rattache les soins curatifs et la prévention.	Le cours y rattache la promotion de la santé et les ressources de résistance.

L'approche salutogénique est rattachée à Aaron Antonovsky et aux années 1970 dans le support. Elle met en avant les ressources de résistance : des facteurs qui aident à maintenir ou améliorer la santé malgré des difficultés ou une maladie.

Note de cours — vivre avec une maladie et des ressources

Une personne vivant avec une maladie chronique peut disposer de ressources psychologiques, d'un entourage soutenant et d'un travail adapté. Elle peut ainsi préserver sa participation sociale et se sentir en bonne santé sur plusieurs dimensions. Cela ne supprime pas la maladie : cela évite de réduire toute sa vie au diagnostic.

À retenir

Pathogénique et salutogénique sont complémentaires : réduire ce qui rend malade et renforcer ce qui permet de vivre en meilleure santé constituent deux portes d'entrée utiles.

4. L'approche intersectorielle : la santé concerne tous les secteurs

L'approche intersectorielle organise la collaboration entre différents secteurs pour agir sur les déterminants de santé et les inégalités. La santé dépend des soins, mais aussi de l'éducation, de l'agriculture, des transports, de l'urbanisme, du logement, de l'environnement et du travail.

Une ville qui facilite la marche et le vélo, une organisation du travail adaptée ou une politique alimentaire mobilisent des acteurs extérieurs au seul système de soins. Le raisonnement consiste à identifier qui peut agir sur la condition en cause, puis à coordonner les interventions.

07 Questions éthiques et posture infirmière

Une intervention de prévention ou de promotion de la santé poursuit un bénéfice, mais soulève aussi des questions sur ses conséquences, les libertés et la justice. Le cours invite à une réflexion collective ; il ne propose pas une réponse automatique valable pour toutes les situations.

Question	Ce qu'il faut examiner
Libertés et choix individuels	Comment concilier protection collective et liberté ? Quelle place laisser aux choix face à une campagne, une obligation ou une incitation ?
Opinions et croyances	Comment transmettre des connaissances sans mépriser les représentations de la personne ni lui imposer une norme stigmatisante ?
Équité et accessibilité	Les messages et les moyens d'action sont-ils accessibles ? Le ciblage d'un groupe est-il justifié et risque-t-il de le discriminer ?
Bénéfices et conséquences défavorables	Qui bénéficie de l'action ? Quelles contraintes ou conséquences négatives entraîne-t-elle pour les personnes ou les groupes ?

Exemple — refus d'un dépistage

Une personne peut ne pas souhaiter un dépistage, notamment par crainte de l'examen ou de son résultat. L'échange doit chercher à comprendre les raisons de ce choix et à expliquer l'objectif de l'action. Le cours utilise cet exemple pour réfléchir à la tension entre bénéfice attendu et autonomie.

Relier la réflexion aux situations de soin

Avant de proposer une action, préciser son objectif, les personnes concernées et les obstacles possibles. Écouter les croyances et les contraintes permet de ne pas confondre désaccord, incompréhension et impossibilité matérielle. La réflexion collective est particulièrement utile lorsque plusieurs intérêts ou valeurs entrent en tension.

Repère pour l'évaluation

L'intervenante annonce des QCM et des questions ouvertes à réponse courte. Elle précise que les classements demandés à l'examen seront plus simples que les exemples discutables débattus en séance ; elle ne demande pas de trancher les controverses éthiques complexes.

08 Comprendre les stratégies et politiques présentées

COMMENT APPRENDRE CES EXEMPLES

Le support indique que ces exemples de programmes et de politiques ne sont pas à apprendre par cœur. Ils servent à comprendre les objectifs et à s'entraîner à justifier une classification. Les modalités citées se rapportent au cours du 9 novembre 2026.

Nutrition et activité physique : PNNS

Le Programme national nutrition santé, créé en 2001 selon le cours, cherche à améliorer la santé en agissant sur l'alimentation et l'activité physique. La nutrition y associe les apports alimentaires et les dépenses liées à l'activité. L'objectif illustré à l'horizon 2030 est une réduction de 30 % du surpoids et de l'obésité chez les enfants et adolescents : c'est un objectif annoncé, pas un résultat obtenu.

Action présentée	Logique pédagogique
Messages Manger Bouger	Éducation pour la santé et promotion de la santé ; prévention primaire et universelle lorsque le message s'adresse à la population générale.
Nutri-Score	Faciliter un choix alimentaire par une information visible : le cours l'utilise aussi comme exemple de nudge. Logiques primaire, universelle et de promotion de la santé.
Septembre bouge	Encourager l'activité physique par des activités et des portes ouvertes locales. Promotion de la santé, prévention primaire ; plusieurs niveaux socio-écologiques et secteurs mobilisés.

L'information nutritionnelle agit sur les aptitudes individuelles ; l'offre d'activités, l'organisation des commerces et l'accessibilité des équipements agissent aussi sur l'environnement. Aucune de ces interventions n'épuise à elle seule les déterminants des comportements.

Santé mentale et psychiatrie

La feuille de route présentée cherche à promouvoir le bien-être mental, améliorer l'accès aux soins et favoriser l'inclusion. Les campagnes d'information tentent de réduire les représentations stigmatisantes. Le travail, les relations sociales et la citoyenneté participent à la santé mentale : l'approche est intersectorielle.

Exemple du cours	Ce qu'il permet de comprendre
Campagne pour parler de santé mentale	Informer et changer les représentations afin de faciliter la demande d'aide ; la réduction à un seul niveau primaire ou secondaire est discutée en séance.
Secourisme en santé mentale	Repérer des signes de difficulté et encourager une orientation vers une aide adaptée. L'exemple oral distingue ce repérage du traitement réalisé par un professionnel.
Dispositif national de prévention du suicide	Le support le classe en prévention secondaire : repérer et prendre en charge rapidement une souffrance avec des idées suicidaires. L'oral discute aussi la limitation des complications.

Exemple du cours	Ce qu'il permet de comprendre
Mon soutien psy	Faciliter l'accès à des consultations psychologiques. Le support retient une logique secondaire ; l'oral souligne que la limitation des complications peut aussi intervenir.

Note de cours — distinguer dispositif et publicité

Une affiche largement diffusée peut faire connaître un dispositif dont les bénéficiaires répondent à des besoins précis. L'universalité de la diffusion ne suffit pas à conclure que toutes les modalités de prise en charge sont universelles.

Lutte contre le tabac

Le programme présenté vise une génération d'adultes non-fumeurs à l'horizon 2032 : les enfants nés depuis 2014 devraient constituer une génération comptant moins de 5 % de fumeurs. Il s'agit d'une cible du programme illustré, non d'une donnée constatée sur les enfants.

Action	Mécanisme et objectif
Mois sans tabac	Encourager l'arrêt et la motivation ; mobiliser le soutien collectif. Prévention primaire des maladies liées au tabac et action orientée vers les fumeurs.
Espaces sans tabac	Créer des environnements favorables à la santé et réduire l'exposition au facteur de risque. Le cours y associe politique publique et prévention primaire.
Paquet neutre et avertissements	Réduire l'attractivité du produit, limiter l'influence du marketing et agir sur les représentations.
Augmentation du prix	Dissuader l'achat par une mesure de politique publique. Comprendre le mécanisme sans retenir un prix comme une valeur fixe.
Mesure concernant les puffs	L'exemple porte sur les cigarettes électroniques jetables et la prévention de l'entrée dans la nicotine, notamment chez les jeunes. Ne pas étendre cette illustration à toutes les cigarettes électroniques.

Note de cours — un soutien aussi social

Le Mois sans tabac agit sur la motivation personnelle mais aussi sur l'idée de faire ensemble. L'arrêt peut être présenté comme un défi partagé, en réponse à la représentation de la cigarette comme moment de sociabilité.

Les 1 000 premiers jours de l'enfant

Dans le support, cette politique couvre le début de la grossesse jusqu'aux deux ans de l'enfant. Elle vise l'accompagnement des parents, le développement de l'enfant et la réduction des inégalités de santé et de développement.

Action présentée	Logiques à reconnaître
Ressources d'aide à la parentalité	Informer et développer les capacités des parents : éducation pour la santé et promotion de la santé.

Action présentée	Logiques à reconnaître
Allongement du congé paternité	Soutenir la famille et la présence du père ; promotion de la santé et prévention primaire des difficultés liées à l'isolement ou à la charge mentale. Le support distingue 25 jours et 3 jours de congé de naissance.
Entretien prénatal précoce	Informer et accompagner, repérer des facteurs de vulnérabilité et des difficultés : plusieurs objectifs, donc plusieurs logiques possibles.
Entretien postnatal précoce	Repérer notamment la dépression du post-partum et donner des conseils de parentalité : secondaire pour le repérage ; éducation et promotion pour l'accompagnement.

Une même consultation peut comporter une composante primaire, secondaire et éducative. Son classement dépend de ce que l'on analyse : éviter une difficulté encore absente, reconnaître un trouble présent ou renforcer les capacités parentales.

Santé sexuelle : droits, information, prévention et accès aux soins

La stratégie présentée vise un accès effectif à la santé sexuelle, aux droits et aux soins tout au long de la vie. Elle associe prévention du VIH et des IST, contraception, IVG, consentement, lutte contre les discriminations et accès aux soins des personnes vulnérables.

Action présentée	Objectif et classement utilisé dans le cours
QuestionSexualité et information	Répondre aux questions, lever les tabous et rendre l'information accessible : éducation pour la santé et promotion de la santé.
Accès à la contraception et aux préservatifs	Réduire les obstacles d'accès. Le cours associe une logique primaire et orientée pour les offres destinées aux jeunes ; distinguer les objectifs selon le moyen présenté.
Vaccination HPV	Empêcher la maladie visée : prévention primaire ; offre orientée vers la population jeune dans l'exemple.
Dépistage des IST	Rechercher une infection déjà possible pour la traiter : prévention secondaire. Le support présente une campagne universelle.
Facilitation de l'accès à l'IVG	Améliorer l'accès aux soins. Les commentaires écrits définitifs du cours retiennent secondaire et orientée pour cet exemple.
EVAR et EVARS	Éducation à la vie affective et relationnelle à l'école ; ajout de la dimension sexuelle au collège et au lycée. Respect de soi et des autres, égalité et protection contre les violences.

> **Bien distinguer les objectifs**
>
> Prévenir une grossesse, prévenir une infection, détecter une infection et faciliter l'accès à un soin ne décrivent pas le même objectif. Ne pas déduire que tous les moyens cités dans une même campagne ont la même fonction.

L'accès aux soins est un déterminant important : une personne peut connaître l'existence d'un problème et rencontrer des difficultés pour trouver une prise en charge. L'information, l'organisation des services et les conditions d'accès doivent donc être examinées ensemble.

09 Une méthode pour analyser une action

Décrire avant de classer

Étape	Question à se poser
1. Définir l'objectif	Quel problème veut-on éviter, détecter ou limiter ? Cherche-t-on à renforcer un pouvoir d'agir ?
2. Situer la maladie	Est-elle absente, possible mais non reconnue, ou déjà diagnostiquée ? La question porte-t-elle sur un soin inutile ?
3. Repérer l'échelle	L'action est-elle organisée pour une personne ou une population ?
4. Identifier la population	S'adresse-t-elle à tous, à un groupe plus exposé, ou à une personne identifiée par ses risques ?
5. Chercher les leviers	Informe-t-elle, développe-t-elle des compétences, modifie-t-elle l'environnement ou l'accès aux soins ? Quels niveaux et secteurs mobilise-t-elle ?

Application — une campagne sur la nutrition

Si elle vise l'ensemble de la population et cherche à prévenir des maladies en aidant à mieux manger, elle peut être primaire, collective et universelle. Elle relève aussi de l'éducation et de la promotion de la santé si elle développe les moyens de choisir. Ces qualifications ne s'excluent pas.

Application — l'entretien après la naissance

Repérer une dépression déjà présente relève de la logique secondaire ; accompagner les parents et leur donner des compétences relève de l'éducation et de la promotion. Il est plus précis de nommer chaque composante que d'imposer un seul niveau à tout l'entretien.

Le classement s'appuie toujours sur l'objectif réellement décrit. Il ne suffit pas de reconnaître un mot comme « affiche », « dépistage », « accès » ou « vaccination » sans considérer la situation et la maladie visée. Les cas discutés en séance montrent que certaines frontières sont débattues ; le cours annonce des situations plus simples pour l'évaluation.

10 Pièges QCM / confusions à éviter

Confusion	Repère pour la corriger
Prévention = seulement avant la maladie	Elle peut aussi détecter tôt une maladie, limiter ses conséquences ou éviter des soins inutiles.
Sans symptômes = pas de maladie	Une phase silencieuse peut exister. C'est une des raisons du dépistage.
Un facteur de risque est déjà la maladie visée	Prévenir un cancer chez une personne exposée au tabac peut relever de la primaire. Il faut nommer la maladie que l'on cherche à éviter.
Le mot dépistage suffit toujours à classer secondaire	Identifier une complication chez un patient dont la maladie est connue s'inscrit dans une logique tertiaire pour cette maladie. Examiner l'objectif.
Prévention tertiaire = simplement traiter	L'objectif caractéristique est de limiter complications, séquelles, incapacités ou rechutes.
Quaternaire = ne plus soigner	Elle vise un soin proportionné et utile, en appréciant bénéfices et risques.
Collective = universelle	Une action collective peut s'adresser à un groupe plus exposé : elle est alors orientée.
Toute campagne a une cible, donc tout est ciblé	Dans Gordon, la prévention ciblée / indiquée est individualisée selon des facteurs de risque.
Promotion = prévention primaire uniquement	Les démarches peuvent se rejoindre, mais la promotion porte sur les capacités et les conditions permettant de maîtriser sa santé.
Informer suffit à éduquer	L'éducation pour la santé vise aussi des compétences et la possibilité concrète d'agir.
Une personne ne change pas parce qu'elle ne veut pas	Les freins peuvent être sociaux, économiques, environnementaux ou liés à l'accès aux soins.
Un nudge est une interdiction	Le nudge incite par l'environnement sans supprimer le choix ni sanctionner.
Être malade exclut toute bonne santé	Le continuum et l'approche salutogénique intègrent les ressources et plusieurs dimensions de la santé.
Santé = seul secteur médical	L'approche intersectorielle associe notamment travail, éducation, logement et transports.
Il faut apprendre tous les exemples par cœur	Le support distingue les notions à connaître et les exemples à comprendre. L'objectif est de justifier le raisonnement.

Vigilance sur les exemples complexes

Ne pas confondre contraception et prévention des IST ; ne pas transformer le cas de réanimation en règle liée à l'âge ; pour l'IVG, retenir le classement corrigé dans les commentaires écrits du support. Ces exemples demandent de distinguer objectif, population et contexte.

11 Synthèse générale — L'essentiel du cours

La santé publique agit collectivement pour la santé physique, mentale et sociale des populations. Elle surveille, protège, prévient, promeut la santé et organise le système de santé. Les déterminants ne sont pas seulement individuels : entourage, conditions de vie, environnement et organisation des soins comptent aussi.

Les quatre niveaux temporels

Primaire : éviter l'apparition de la maladie. Secondaire : reconnaître tôt une maladie possible et agir précocement. Tertiaire : limiter les conséquences d'une maladie connue. Quaternaire : éviter les soins inutiles ou disproportionnés.

Deux autres critères complètent ce classement : individuelle ou collective pour l'échelle de l'action ; universelle, orientée / sélective ou ciblée / indiquée pour la population. Toujours dire quel critère on utilise. Une même intervention peut recevoir plusieurs qualifications compatibles.

La promotion de la santé donne aux populations davantage de contrôle sur leur santé. Ottawa associe cinq axes : politiques pour la santé, environnements favorables, action communautaire, aptitudes individuelles et réorientation des services. L'éducation pour la santé développe à la fois les connaissances et les compétences permettant des décisions éclairées.

Un comportement ne dépend pas uniquement du savoir ou de la volonté. Motivation, représentations, entourage, ressources économiques, environnement et accès aux soins peuvent aider ou freiner le changement. Un nudge agit sur le contexte du choix ; une démarche éducative développe aussi les capacités de la personne.

Les approches socio-écologique, par milieux de vie, salutogénique et intersectorielle permettent d'agir sur plusieurs dimensions. L'approche pathogénique cherche ce qui rend malade ; l'approche salutogénique cherche ce qui permet d'aller vers une meilleure santé. Elles sont complémentaires.

Les politiques de nutrition, santé mentale, lutte contre le tabac, parentalité et santé sexuelle illustrent ces principes. Leur analyse doit garder l'objectif, les bénéficiaires et les conditions d'accès au centre. L'éthique demande aussi de réfléchir aux libertés, à l'équité, à la stigmatisation et aux conséquences de chaque action.

Le réflexe à mémoriser

Quel objectif ? À quel moment de la maladie ? À quelle échelle ? Pour quelle population ? Avec quels leviers ? Cette suite de questions permet de classer sans confondre les critères.

12 Définitions et mots-clés

Les définitions reprennent le sens utilisé dans ce cours. Les termes proches sont à distinguer par leur objectif et leur contexte.

Terme	Définition
Santé publique	Action collective et concertée visant à préserver et améliorer la santé des populations, au-delà du seul soin individuel.
Santé	Dans les rappels du cours, elle comprend les dimensions physique, mentale et sociale ; elle ne se résume pas à l'absence de maladie.
Déterminant de santé	Facteur personnel, social, économique ou environnemental qui influence favorablement ou défavorablement l'état de santé.
Facteur de risque	Caractéristique, exposition ou comportement associé au risque d'apparition d'un problème de santé ; c'est un point d'action possible en prévention.
Veille sanitaire	Surveillance de l'état de santé et de ses évolutions afin de repérer des signaux inhabituels ou des menaces.
Maladie chronique	Maladie qui s'inscrit dans la durée et peut nécessiter un accompagnement et une prévention de ses complications.
Espérance de vie à la naissance	Indicateur de durée moyenne de vie présenté dans le cours ; sa valeur historique est notamment influencée par la mortalité infantile.
Prévention	Ensemble de mesures visant à éviter ou réduire le nombre ou la gravité des maladies, accidents et handicaps.
Histoire naturelle de la maladie	Succession des étapes allant du début du processus biologique à la détection et à l'évolution de la maladie.
Asymptomatique	Qui ne présente pas de symptômes perceptibles ; une maladie peut néanmoins être présente.
Prévention primaire	Intervenir avant l'apparition de la maladie visée pour empêcher sa survenue, notamment en réduisant les facteurs de risque.
Prévention secondaire	Détecter précocement une maladie possible et faciliter sa prise en charge pour en limiter la gravité.
Dépistage	Recherche d'une maladie potentiellement présente mais non encore reconnue, notamment en l'absence de symptômes.
Prévention tertiaire	Limiter les complications, rechutes, séquelles et incapacités d'une maladie déjà connue.
Séquelles	Conséquences qui persistent après une maladie ou un événement de santé.
Rechute	Réapparition ou reprise d'une maladie après une amélioration.
Complication	Problème supplémentaire pouvant survenir au cours ou à la suite d'une maladie.

Terme	Définition
Prévention quaternaire	Recherche du juste soin pour éviter la surmédicalisation et des interventions inutiles ou défavorables.
Balance bénéfice-risque	Mise en regard des bénéfices attendus et des risques d'une action pour décider de sa pertinence dans une situation.
Surmédicalisation	Recours excessif ou inapproprié à des interventions médicales, que la prévention quaternaire cherche à éviter.
Pluridisciplinaire	Qui mobilise plusieurs disciplines ou professionnels dans une réflexion ou une prise en charge.
Prévention individuelle	Mesure mise en œuvre pour une personne, adaptée à sa situation et à ses risques.
Prévention collective	Mesure organisée à l'échelle d'une population, par exemple une campagne de vaccination ou un dépistage organisé.
Prévention universelle	Dans Gordon, action destinée à l'ensemble d'une population sans distinction du niveau de risque individuel.
Prévention orientée / sélective	Dans Gordon, action destinée à un groupe dont le risque est statistiquement plus élevé que la moyenne.
Prévention ciblée / indiquée	Dans le cours, action individualisée pour des personnes identifiées selon leurs facteurs de risque.
Promotion de la santé	Processus permettant aux populations de mieux contrôler et améliorer leur santé en renforçant leurs capacités et leurs conditions de vie.
Charte d'Ottawa	Référence de 1986 organisant la promotion de la santé autour de cinq axes complémentaires.
Action communautaire	Participation active d'une communauté aux décisions et aux projets qui concernent sa santé.
Environnement favorable	Milieu dont les caractéristiques facilitent la santé et les comportements favorables.
Aptitudes individuelles	Capacités et compétences permettant à une personne de faire des choix et d'agir sur sa santé.
Éducation pour la santé	Possibilités d'apprendre et communication visant des connaissances et compétences utiles à des décisions favorables à la santé.
Littératie en santé	Dans le périmètre du cours, capacités à comprendre et utiliser l'information sur la santé pour agir et décider.
Comportement de santé	Action, habitude ou conduite qui influence la santé, de façon favorable ou défavorable.
Frein / levier	Élément qui rend un changement de comportement plus difficile / plus facile.
Nudge	Incitation modeste par l'organisation de l'environnement, sans sanction ni suppression de la liberté de choix.

Terme	Définition
Représentations sociales	Croyances, connaissances et opinions produites et partagées dans un groupe à propos d'un objet social.
Stigmatisation	Regard négatif porté sur une personne ou un groupe, pouvant notamment freiner la demande d'aide ou l'accès aux soins.
Approche socio-écologique	Lecture de la santé articulant niveaux individuel, interpersonnel, organisationnel, communautaire et politiques publiques.
Approche par milieux de vie	Intervention dans les lieux du quotidien pour les rendre favorables à la santé.
Vision dichotomique	Opposition entre deux catégories exclusives : malade ou en bonne santé.
Continuum de santé	Vision dynamique et graduée de la santé, qui ne se réduit pas à deux états opposés.
Pathogenèse / approche pathogénique	Processus conduisant à la maladie / approche étudiant ce qui rend malade pour prévenir et soigner.
Salutogenèse / approche salutogénique	Processus conduisant vers la santé / approche étudiant les ressources qui permettent de la maintenir ou de l'améliorer.
Ressources de résistance	Facteurs personnels, sociaux ou matériels aidant une personne à rester en meilleure santé malgré les difficultés ou la maladie.
Approche intersectorielle	Collaboration de plusieurs secteurs de la société pour agir sur les déterminants et les inégalités de santé.
Équité et accessibilité	Questions portant sur la justice des interventions et sur la possibilité réelle, pour les personnes, d'accéder aux messages, moyens et soins.
PNNS	Programme national nutrition santé : alimentation et activité physique comme leviers de santé.
HPV	Papillomavirus humains ; le cours présente leur vaccination comme un exemple de prévention primaire.
IST / VIH	Infections sexuellement transmissibles / virus de l'immunodéficience humaine ; notions citées dans la stratégie de santé sexuelle.
IVG	Interruption volontaire de grossesse ; l'exemple du cours porte sur l'amélioration de l'accès aux soins.
EVAR / EVARS	Éducation à la vie affective et relationnelle / éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Post-partum	Période après l'accouchement, abordée à propos de la santé des parents et du repérage de la dépression.
AVC	Accident vasculaire cérébral ; exemple utilisé pour la rééducation et la prévention des complications ou récidives.